Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível

Autos n.° 0811608-14.2021.8.12.0002
Ação: Procedimento Comum Cível

Vistos etc.

Paulo Renato Calabretta Staut, já qualificado na inicial, ingressou com ação de obrigação de fazer c.c. e tutela de urgência em desfavor de Bradesco Saúde S/A, também qualificado, pois é portador de adenocarcinoma de pâncreas com metástase hepática (CID: C25) e necessita do medicamento Olaparibe (nome comercial Lynparza), o qual o plano de saúde tem a obrigação de fornecer. Pede a concessão de tutela urgência para obrigar a ré a lhe entregar o medicamento durante seu tratamento médico, por tempo indeterminado, bem como a condenação definitiva, além dos ônus sucumbenciais (f. 1-15).

Instruiu com o contrato de seguro coletivo empresarial de reembolso de despesas de assistência médico-hospitalar, relatório médico e diagnóstico médico (f. 34-69), negativa da requerida (f. 70), entre outros.

Mod. 721315 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 07/06/2022 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0811608-14.2021.8.12.0002 e código jQyHRUq0.

Ordem para comprovação da hipossuficiência econômica (f. 97).

O autor comprovou o pagamento das custas (f. 101-6).

Concedida a tutela de urgência (f. 108-15).

Citação (f. 130).

Audiência de conciliação sem composição (f. 154).

Em contestação, Bradesco Saúde S/A afirma que o rol da Resolução Normativa n.º 428/2017 Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS é taxativo e não prevê cobertura obrigatória de Olaparibe (nome comercial Lynparza), além disso, no contrato pactuado, há exclusão expressa de tratamentos não elencados pelo rol da agência reguladora, logo, inexiste obrigação do plano de saúde em fornecer o medicamento. Por esse motivo, não há que se falar em abusividade contratual ou constrangimento que deem azo a danos morais que, caso eventualmente fixados, devem ser em patamares moderados. Pugna, ao final, pela improcedência e condenação nos consectários legais (f. 165-79). Acostou documentos (f. 180-243).

Impugnação à contestação (f. 194-213).

O E. TJMS manteve a decisão que concedeu a tutela de urgência (f. 237-46).

Saneamento do feito (f. 257-74).

Designada audiência de instrução (f. 281).

As partes desistiram da oitiva de testemunhas e apresentaram alegações finais remissivas à inicial e à contestação (f. 304).

É o relatório.

Decido.

O autor é portador de adenocarcinoma de pâncreas com metástase hepática (CID: C25) e necessita do medicamento Olaparibe (nome comercial Lynparza), conforme se vê às f. 69:

Mod. 721315 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 07/06/2022 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0811608-14.2021.8.12.0002 e código jQyHRUq0.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível

Relatório Médico a pedido do paciente

O Sr. PAULO RENATO CALABRETTA STAUT é portador de Adenocarcinoma de Pâncreas - EC IV com metástase hepática ao diagnóstico (confirmada por biópsia).

Realizou quimioterapia com esquema FOLFIRINOX de 13/11/2020 a 15/06/2021 e apresentou excelente resposta a tratamento (resposta metabólica completa em PET-CT de abril/21 e julho/21).

O Sr. Paulo é portador de mutação germinativa dos genes BRCA 2 (FoundationOne). As mutações germinativas do gene BRCA afetam até 7% dos pacientes portadores de câncer de pâncreas. Tais alterações são classicamente caracterizadas pela sensibilidade ao tratamento com inibidores da PARP, possibilitando o uso de terapias-alvo para essa doença.

Aumentando as opções de tratamento para esse grupo selecionado de pacientes, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o uso de olaparibe como terapia de manutenção em pacientes com mutações germinativas de BRCA que não tenham progredido durante tratamento de primeira linha com quimioterapia baseada em platina, de acordo com os resultados do estudo de fase III **POLO**.

Neste estudo, 154 pacientes com adenocarcinoma de pâncreas avançado portadores de mutação germinativa no gene BRCA foram randomizados a uma razão 3:2 para receberem olaparibe ou placebo como terapia de manutenção após o tratamento com uma linha de quimioterapia baseado em platina à escolha do investigador (a maioria da população recebeu FOLFIRINOX, FOLFOX ou GEMOX). O objetivo primário do estudo foi atingido, demonstrando que o uso de olaparibe reduziu em 47% o risco relativo de progressão de doença ou morte quando comparado a placebo (HR=0,53; IC de 95%: 0,35-0,82; p=0,004), prolongando a sobrevida livre de progressão mediana de 3,8 para 7,4 meses. Dentre os objetivos secundários, a taxa de resposta objetiva no grupo de pacientes tratados com olaparibe foi 23%. Com apenas 46% dos desfechos, a análise de sobrevida global ainda é imatura. Adicionalmente, uma análise complementar do estudo demonstrou que o tratamento com olaparibe não teve impacto negativo na qualidade de vida relacionada à saúde.

Pelos dados acima descritos, solicito terapia de manutenção com olaparibe na dose de 300 mg VO 2×/dia, continuadamente por tempo indeterminado ou até progressão da doença.

N Engl J Med. 2019 Jul 25;381(4):317-327

CID: C25 - NEOPLASIA MALIGNA DO PÂNCREAS - IV

Dra. Viviane Andresatta Rivto
Oncologia
CRM-MS 4885 / RQE 3056

O cerne da questão é se o fato do medicamento prescrito ao autor, Olaparibe (nome comercial Lynparza), não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS para tratamento do câncer, é motivo para a recusa do fornecimento. Nesse contexto, importante analisar a disciplina legal sobre o tema.

A Lei n.º 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde e os seguros privados de assistência à saúde, instituiu no seu artigo 12 que, quando incluída cobertura ambulatorial e internação hospitalar, serão fornecidos medicamentos antineoplásicos, verbis:

> *"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguro privados de assistência à saúde que contenham redução ou extensão da cobertura assistencial e do padrão de conforto de internação hospitalar, em relação ao plano referência*

Mod. 721315 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 07/06/2022 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0811608-14.2021.8.12.0002 e código jQyHRUq0.

definido no art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;(...) II - quando incluir internação hospitalar: (...) d) medicamentos, anestésicos, oxigênio, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar;"

Além do fornecimento de medicamentos para combate ao câncer ser de cobertura obrigatória, no caso em tela, o autor aderiu ao plano de saúde oferecido pela ré, com cobertura para tratamento ambulatorial e internação hospitalar (f. 21-68) que, segundo o contrato de prestação de serviços, cobre quimioterapia ambulatorial, vejamos às f. 34:

3.2. Cobertura Ambulatorial
A seguradora indenizará as despesas realizadas com consultas médicas, exames e terapias, bem como as decorrentes de cirurgias ambulatoriais que não necessitem de internação hospitalar.

3.2.1. Consultas Médicas
A seguradora indenizará as despesas provenientes de consultas médicas prestadas por clínicos ou especialistas legalmente habilitados.

3.2.2. Exames Clínicos e Laboratoriais
A seguradora indenizará as despesas com os seguintes exames, quando realizados por indicação médica:
a) análises clínicas;
b) anatomopatologia;
c) radiologia;
d) eletrocardiografia;
e) eletroencefalografia simples;
f) ultra-sonografia;
g) endoscopias em geral; e
h) outros exames constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previsto na regulamentação editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e suas atualizações.

3.2.2.1. Para a realização, na Rede Referenciada, dos exames de que trata a alínea "h" do subitem 3.2.2, deverá ser solicitada prévia autorização à seguradora.
3.2.3. Terapias
A seguradora indenizará as seguintes despesas, quando realizadas por indicação médica:
a) fisioterapia por acidente ou por doença;
b) quimioterapia ambulatorial;
c) radioterapia;
d) litotripsia;
e) hemodiálise e diálise peritoneal;
f) hemoterapia ambulatorial;

O contrato prevê atendimento ambulatorial e internação hospitalar, ambas com cobertura para quimioterapia e o artigo 12, da Lei n.º 9.656/98, dispõe pela obrigatoriedade da entrega de antineoplásicos domiciliares de uso oral, logo, o plano de saúde não pode negar o medicamento prescrito pela médica responsável, ainda que o método indicado para cura do paciente ou diminuição dos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 07/06/2022 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0811608-14.2021.8.12.0002 e código jQyHRUq0.

efeitos da doença não conste em rol de procedimentos da ANS, sendo certo, que este rol é meramente exemplificativo. Neste sentido já decidiu o E. TJMS:

> "*AGRAVO DE INSTRUMENTO- TUTELA DE URGÊNCIA- PLANO DE SAÚDE - COBERTURA DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTO ESPECÍFICO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA - CÂNCER – ROL DA ANS – EXEMPLIFICATIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.*" (TJMS, Agravo de Instrumento n.º 1407544-49.2020.8.12.0000, 1.ª Câmara Cível, Relator Desembargador Geraldo de Almeida Santiago, julgado em 21.9.2020).
>
> "*APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MATERIAIS – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO ONCOLÓGICO – PACIENTE COM CÂNCER DE PULMÃO METASTÁTICO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDICADO PELOS ESPECIALISTAS SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE NÃO ESTÁ NO ROL DO ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – RECUSA INJUSTIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese o tratamento pleiteado não constar no rol das Resoluções Normativas da ANS, tal fato não exime o plano de saúde em fornece-lo, uma vez que se trata de um rol mínimo, meramente exemplificativo e sem caráter vinculativo. Conforme posicionamento do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, porém não o tipo de tratamento médico a ser realizado para a cura ou melhora do quadro de saúde do paciente. No caso dos autos, o "ALECENSA" é indicado especificamente para tratamento de câncer de pulmão que acomete o autor, encontra-se registrado na ANVISA e foi indicado pelo médico que acompanha o paciente, não cabendo, portanto, qualquer discussão acerca de terapia alternativa para a doença a fim de justificar a negativa de fornecimento do medicamento, até porque a indicação do produto foi feita pelo especialista que acompanha o paciente e baseado em estudos e referência bibliográfica.*" Negritei (TJMS, Apelação Cível n. 0804642-89.2018.8.12.0018, 2.ª Câmara Cível, Relator Desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho, julgado em 28.11.2019)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 07/06/2022 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0811608-14.2021.8.12.0002 e código jQyHRUq0.

A 3.ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que operadora do plano de saúde não pode limitar o tratamento, vejamos:

> "*AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 2. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. (...). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.*" Destaquei (STJ, AgRg no AREsp 708.082/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, 3.º Turma, julgado em 16.2.2016, DJe 26.2.2016).
>
> "*AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível,prescrito para garantir a*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 07/06/2022 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0811608-14.2021.8.12.0002 e código jQyHRUq0.

saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020) 2. A orientação deste Tribunal Superior também é na direção de que "é abusiva a negativa de cobertura para o tratamento prescrito pelo médico para o restabelecimento do usuário de plano de saúde por ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, em razão de ser ele meramente exemplificativo (AgInt no REsp 1682692/RO, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019,DJe 06/12/2019) 3. Esta Corte de Justiça entende, ainda, que "há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente." (REsp 1.642.255/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). 4. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sendo que há a sua ocorrência quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto. 5. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 6. Agravo interno improvido." Destaquei (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1642079/SP, 3.ª Turma, Relatora Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24.8.2020)

Recente decisão pela 4.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.733.013/PR, pela validade da limitação de tratamento, não é vinculativa, pois não proferida em sede de recurso repetitivo, sem servir, portanto, como Acórdão Paradigma (artigo 1.036 e artigo 1.040, iniciso IV, ambos do CPC). Ademais, como visto anteriormente, a 3.ª Turma do Tribunal da Cidadania tem

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 07/06/2022 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0811608-14.2021.8.12.0002 e código jQyHRUq0.

entendimento diverso, isto é, que o rol é exemplificativo e incabível a limitação do tratamento, posicionamento este adotado pelo juízo.

Isso também se justifica pelo fato de serem as normas da ANS de caráter infralegal, logo, não podem restringir o alcance da Lei n.º 9.656/98. Outrossim, a 2.ª Seção do STJ já decidiu que o plano de saúde somente pode recusar medicamento não previsto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA. Transcrevo a seguir a Ementa do REsp. n.º 1.712.163:

> *"RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76. Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nº 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 2.4. Em virtude da parcial reforma do acórdão recorrido, com a redistribuição dos ônus da sucumbência, está prejudicado o recurso especial manejado por ONDINA.*
> *3. Recurso especial interposto pela AMIL parcialmente provido. Recurso especial manejado por ONDINA prejudicado. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 07/06/2022 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0811608-14.2021.8.12.0002 e código jQyHRUq0.

> *NCPC."* (REsp 1712163/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).

Pois bem, conforme julgado acima transcrito, a imposição do artigo 12, da Lei n.º 9.656/98 não abrange os fármacos não registrados na ANVISA, sendo lícita a recusa pelo plano de saúde nesta hipótese. Não é o caso dos autos, em acesso ao sítio eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é possível consultar o registro do fármaco objeto da lide (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=25829) , vejamos:

Consultas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Consultas / Medicamentos / Medicamentos

Resultado da Consulta de Produtos

	Nome Comercial	Princípio Ativo	Registro	Processo	Nome da Empresa Detentora do Registro – CNPJ	Situação	Vencimento
☑	Lynparza comprimidos	olaparibe	116180268	25351.551167/2017-31	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - 60.318.797/0001-00	Válido	10/2028

Não descuro a existência da cláusula 5.º com exclusão de especialidades e serviços não enquadrados no Rol de Procedimentos através da resolução do Ministério da Saúde, inclusive fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (f. 200). Contudo, tal disposição contratual infringe a norma cogente do artigo 12, da Lei n.º 9.656/98, que determinada a cobertura obrigatória de medicamentos para tratamento antineoplástico, conforme citado anteriormente. Logo, a cláusula que excluiu o fornecimento de medicamentos de forma genérica é abusiva, ou seja, nula de pleno direito, mormente por se tratar de relação consumerista e contrariar determinação legal.

É importante anotar também que o § 4.º, do artigo 12, da Lei n.º 9.656/96 não tem o condão de restringir o acesso dos usuários aos medicamentos, tão somente indicar que protocolos clínicos sobre os fármacos antineoplásicos serão publicados periodicamente. Novamente julgado que ampara a tese adotada:

> *"PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO APALUTAMIDA – FÁRMACO INDICADO PELO MÉDICO DO PACIENTE PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA – COMPROVADO REGISTRO NA ANVISA – ROL DE*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 07/06/2022 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0811608-14.2021.8.12.0002 e código jQyHRUq0.

PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA DEVIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 102 DESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – A ELEIÇÃO DO TRATAMENTO COMPETE AO MÉDICO E NÃO À SEGURADORA – PRECEDENTES DESSA CÂMARA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO." (TJSP; Agravo de Instrumento 2229303-80.2019.8.26.0000; Relator (a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 4ª Vara; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019).

Dessa forma, como há cobertura para quimioterapia, o rol de procedimento da ANS é meramente exemplificativo e o remédio pretendido é registrado na ANVISA, é indevida a recusa da ré em fornecer o Olaparibe (nome comercial Lynparza), mormente porque se funda em cláusula contratual abusiva. Tal conclusão decorre tanto do Código de Defesa do Consumidor, quanto das obrigações atinentes aos planos de saúde para com seus aderentes.

Logo, faz jus o requerente ao recebimento do medicamento pretendido na inicial, durante o tempo necessário para seu tratamento indicado pela médica.

Por fim, inexiste na inicial pedido de indenização por danos morais, ao que deixo de analisar as alegações quanto a esta matéria apresentada na contestação pela ré.

Diante do exposto e mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 12, da Lei n.º 9.656/98, julgo procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer por Paulo Renato Calabretta Staut para obrigar Bradesco Saúde S/A ao fornecimento do medicamento Olaparibe (nome comercial Lynparza) durante todo o tempo que o tratamento perdurar, conforme prescrição médica (f. 69).

Mantenho a tutela de urgência anteriormente concedida, em caso de recurso.

Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à patrona do autor em 10% do valor da causa, corrigido pelo INPC/IBGE desde a propositura da ação até efetivo pagamento, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e tempo despendido, nos moldes do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Mod. 721315 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 07/06/2022 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0811608-14.2021.8.12.0002 e código jQyHRUq0.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível

Julgo o processo com resolução do mérito a teor do artigo 487, inciso I, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.R.I.

Dourados-MS, 7 de junho de 2022.

César de Souza Lima
Juiz de Direito

Mod. 721315 - Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 210, prédio anexo, Centro - CEP 79804-030, Fone: (67) 3902-1732, Dourados-MS - E-mail: dou-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 07/06/2022 às 17:30 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0811608-14.2021.8.12.0002 e código jQyHRUq0.